

Геморрагическая болезнь новорождённого

Витамин К: профилактика при рождении · дозы при кровотечении · поздняя форма

1. ТРИ ФОРМЫ — И РАЗНЫЕ СРОКИ

Форма	Когда	Чем проявляется	Профилактика работает?
Ранняя	Первые 24 часа	Кровавая рвота, лёгочное кровотечение, мелена, кровоизлияния в органы брюшной полости и надпочечники	Нет: связана с приёмом матерью препаратов, нарушающих обмен витамина К
Классическая	2-7-е сутки	Желудочно-кишечные кровотечения, кожные геморрагии, кровотечение из пупочной ранки, мест инъекций, слизистых. Внутрочерепные — нетипичны	Да, если витамин К введён сразу после рождения
Поздняя	8-е сутки – 6 месяцев, пик 2-12 недель	Внутрочерепные кровоизлияния в 50-75% случаев: субдуральные 40%, паренхиматозные 40%, внутрижелудочковые 10%, субарахноидальные 10%	Да, профилактикой и поддержкой при холестазах

Поздняя форма предупреждает о себе заранее

Более чем у трети детей за время от суток до нескольких недель **до** кровоизлияния в мозг появляются экхимозы и мелкие геморрагии. Синяк у ребёнка 2-12 недель на исключительно грудном вскармливании без профилактики витамином К — это повод проверить коагулограмму сегодня, а не наблюдать.

2. КРИТЕРИИ ДИАГНОЗА

Что	Значение
Клинически	Спонтанное кровотечение любой локализации
Протромбиновое время	Удлинено в 4 раза и более
МНО	≥ 4, ПТИ резко снижен
АЧТВ	Удлинено
Фибриноген и тромбоциты	В норме — это отличает от ДВС и тромбоцитопении
Подтверждение	Нормализация ПВ после введения витамина К

Если ПВ и АЧТВ выше возрастной нормы, но до этих значений не дотягивают, а ребёнок кровит — КР предписывают трактовать случай как **подозрение на геморрагическую болезнь** и лечить, а не ждать.

3. КТО В ГРУППЕ РИСКА

Форма	Что искать
Ранняя	Приём матерью антагонистов витамина К, противоэпилептических препаратов
Классическая	Недостаточное поступление молока, отсутствие профилактики сразу после рождения
Поздняя	Холестаз, синдром мальабсорбции, исключительно грудное вскармливание без профилактики витамином К
Отдельно	Незрелость, асфиксия при рождении, застойная желтуха, расстройство глотания — группа повышенного риска кровотечений

Отягощённый семейный анамнез по геморрагическим заболеваниям для этой болезни **нехарактерен**: если он есть — думать о наследственной коагулопатии.

4. ПРОФИЛАКТИКА ПРИ РОЖДЕНИИ

Кому	Доза	Путь
ГВ ≥ 36 недель	1 мг	Внутримышечно, при рождении или сразу после
ГВ < 36 недель при массе ≥ 2,5 кг, а также группа повышенного риска	1 мг однократно	Внутримышечно или внутривенно
ГВ < 36 недель при массе < 2,5 кг	0,4 мг/кг (0,04 мл/кг)	Внутримышечно или внутривенно

Готовые дозы фитоменадиона 1% для недоношенных — таблица 1 КР

Масса тела	Доза	Объём
1 кг	0,4 мг	0,04 мл
1,5 кг	0,6 мг	0,06 мл
2 кг	0,8 мг	0,08 мл
2,5 кг	1,0 мг	0,1 мл
более 2,5 кг	1,0 мг	0,1 мл

Внутривенно — только разведённым
Перед внутривенным введением эмульсию разводят **1:5** водой для инъекций или 5% декстрозой и вводят медленно: примерно **1 мл за 20 секунд**. Количество последующих доз и их периодичность зависят от статуса свёртывания.

5. ЕСЛИ РОДИТЕЛИ ОТКАЗАЛИСЬ ОТ ИНЪЕКЦИИ

КР прямо предусматривают этот случай и предлагают альтернативу — **пероральный фитоменадион 1%**:

Когда	Доза внутрь
После рождения	2 мг
На 4-6-е сутки	2 мг
В 4-6 недель	2 мг

Если в течение часа после приёма была рвота или срыгивание — повторить дозу. Схема из трёх приёмов работает только целиком: третий приём как раз закрывает пик поздней формы.

6. ЛЕЧЕНИЕ ПРИ КРОВОТЕЧЕНИИ

Вводить, не дожидаясь лаборатории
Ребёнку с кровотечением и подозрением на геморрагическую болезнь витамин К вводится **немедленно**, до лабораторного подтверждения. Нормализация ПВ после введения и станет подтверждением диагноза.

Препарат	Доза	Замечания
Фитоменадион 1%	Как в профилактике: 1 мг, у недоношенных < 2,5 кг — 0,4 мг/кг	Препарат выбора. Дальнейшие дозы — по коагулограмме
Менадиона натрия бисульфит 1% (при отсутствии фитоменадиона)	1-1,5 мг/кг/сут (0,1-0,15 мл/кг/сут), не более 4 мг/сут ; 1-3 раза в сутки, курс 2-4 дня	Действие начинается только через 8-24 часа. Повторить курс можно после 4-дневного перерыва
Свежезамороженная плазма	10-20 мл/кг внутривенно	При продолжающемся и жизнеугрожающем кровотечении, одновременно с витамином К. Вводить не быстрее 60 минут и не дольше 4 часов

Противопоказания менадиона
Гиперкоагуляция, тромбоз, **гемолитическая болезнь новорождённых**. С осторожностью — при дефиците ГбФД. Это не замена фитоменадиона «по умолчанию», а вариант, когда фитоменадиона нет.

7. ПОДДЕРЖКА ПРИ ХОЛЕСТАЗЕ, МАЛЬАБСОРБЦИИ И ПАРЕНТЕРАЛЬНОМ ПИТАНИИ

Масса менее 5 кг	1 мг/кг раз в неделю	Масса более 5 кг	2,5-5,0 мг от 1 до 3 раз в неделю или 10 мг раз в 2 недели
Путь введения	При холестазе и мальабсорбции — парентерально: жирорастворимый витамин всасывается плохо	Контроль	МНО, при необходимости ПВ и ПТИ — доза подбирается по коагулограмме, в тяжёлых случаях вплоть до ежедневного приёма

8. ЧТО МОЖЕТ СДЕЛАТЬ МАТЬ

- Кормящей женщине — продукты, богатые витамином К₁, и поливитамины с витамином К₁: это повышает концентрацию витамина в грудном молоке.
- Само по себе это **не заменяет** профилактику у ребёнка: перенос витамина К через плаценту ограничен, запасы в печени новорождённого малы, а период полураспада витамин-К-зависимых факторов короткий.

ИСТОЧНИКИ

— Клинические рекомендации МЗ РФ «Геморрагическая болезнь плода и новорожденного» — ID 906_1, размещены 15.04.2025. https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/906_1

— Клинические рекомендации МЗ РФ «Неонатальный холестаз» — ID 959_1, размещены 31.10.2025. https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/959_1

— Формы, лабораторные критерии, дозы и схемы приведены по разделам 1.5, 2, 3 и 5 КР «Геморрагическая болезнь плода и новорождённого»; таблица доз для недоношенных — таблица 1 тех же КР.